·监督与管理·

门诊护患沟通障碍案例分析及应对措施

刘希玲

陆军第七十四集团军医院门诊部，广东　广州　510200

摘要：目的 通过分析门诊护患沟通障碍的案例，制定解决门诊护患沟通障碍的对策，旨在构建和谐的护患关系，避免冲突，减少纠纷。**方法** 选择2022年1月—2023年12月陆军第七十四集团军医院门诊就诊发生门诊投诉、医疗纠纷及接受了患者满意度调查的108份护患沟通障碍案例为本次研究对象，收集了发生纠纷人员的一般信息、纠纷发生地点、发生原因、具体事件、处理过程及处理结果；提取患者满意度调查的相关数据，包括就诊科室、就诊原因、满意度调查结果、患者意见等数据，建立护患沟通障碍数据库，进行频数统计。**结果** 经过数据处理共提取了14个护患沟通障碍的类型。其中，费用问题出现的频次最高，共计18次，占16.67%，包括各项检查费、药品费等；最少频次的是护理人员专业知识缺乏，共计2次，占1.85%。护患沟通障碍的表现形式主要是投诉，共计56次，占51.85%；频次最少的是以医疗纠纷形式出现，共计17次，占15.74%；应邀参与门诊满意度调查的22例，占20.37%；主动参与门诊满意度调查的13例，占12.04%。**结论** 护患沟通障碍案例分析有助于明确护患沟通障碍发生的原因并寻找有效对策，从而保障患者安全顺利就诊。

关键词：门诊；护患沟通；护患关系；沟通障碍

中图分类号：R195　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1003-5052(2026)02-190-03　　**DOI:**10.16286/j.1003-5052.2026.02.065

门诊是医疗机构为不需要或者尚未住院的有健康需求的群众防治疾病的一种方式。门诊工作具有非常鲜明的特点，患者集中、人流量大、病种多而复杂、管理困难等。此外，门诊又是展示医院服务质量、形象的重要窗口。门诊护士作为接触门诊患者的第一人，其与就诊对象的沟通至关重要[1]。门诊护患关系紧张与护患沟通障碍、沟通不良紧密相关[2]。本研究通过分析门诊护患沟通障碍案例，寻找有效的应对措施，旨在提高门诊护患沟通的有效性，提高患者门诊就诊体验感。

1　资料与方法

1.1　*临床资料*　选择2022年1月—2023年12月我院门诊就诊发生门诊投诉、医疗纠纷及接受了患者满意度调查的108份护患沟通障碍案例为本次研究对象，已通过医院伦理委员会的审查和批准。

1.2　*方法*

1.2.1　资料收集和质量控制　依托门诊部投诉管理系统，导出研究期间每月投诉、医疗纠纷和患者满意度的相关数据，提取发生纠纷的人员信息、纠纷发生地点、发生原因、具体事件、处理过程及处理结果；提取患者满意度调查的相关数据，包括就诊科室、就诊原因、满意度调查结果、患者意见等。由3名课题组人员对相关资料进行整理、核对，并收集录入Excel表格中。本研究所有成员均接受了统一的培训，明确各自负责的具体分工、任务，实行平面化管理，项目负责人负责整个课题的设计、实施、工作进度及质量管理。

1.2.2　护患沟通障碍的分类　由2名研究人员对纳入资料的护患沟通障碍进行规范化分类，当2名研究人员在归类时存在分歧，可与指定的主任护师进行商议后再确定归入哪一类。比如患者首次来就诊不知道看哪个科室？但因门诊人太多需要在预检分诊处排队咨询，患者拒绝排队，插队到咨询台在不顾其他患者问询的同时提出问题，未得到及时回答而投诉，我们规范为“医院资源配置欠合理”，而不是“患者问题未及时解答”。

1.3　*统计学处理*　采用SPSS 26.0软件进行数据分析。计量资料采用均数±标准差($\bar{x}\pm s$)进行表示，计数资料采用频数和构成比n(%)进行表示，护患沟通障碍进行频数统计。

2　结　果

2.1　*一般资料结果*　共收集到108份研究资料，患者的年龄分布在23~68岁，平均(40.26±11.35)岁，年龄平均在中年水平，女性68人，男性40人，女性占比高于男性。护理人员的年龄分布在28~48岁，平均

作者简介：刘希玲，本科，主管护师，研究方向：门诊护患关系

通信作者：刘希玲，E-mail：854682285@qq.com

中国知网　https://www.cnki.net

(35.00±7.34)岁,工作年限平均(10.35±4.18)年。患者学历以大专及以下居多,为70人,占64.81%,家庭人均月收入以<1 900元组居多,为83人,占76.85%,首次就诊患者88人,占81.48%,见表1。

表1 发生护患沟通障碍的患者和护士的基本情况 (n=108)

项目	数值
患者情况	
性别[n(%)]	
男性	40(37.04)
女性	68(62.96)
年龄($\bar{x}\pm s$,岁)	40.26±11.35
受教育程度[n(%)]	
初中及以下	9(8.33)
高中	26(24.07)
大专	35(32.41)
本科	20(18.52)
研究生	18(16.67)
家庭人均月收入[n(%)]	
<1 900元	83(76.85)
≥1 900元	25(23.15)
首次就诊[n(%)]	
是	88(81.48)
否	20(18.52)
护士情况	
年龄($\bar{x}\pm s$,岁)	35.00±7.34
工作年限($\bar{x}\pm s$,年)	10.35±4.18

2.2 *护患沟通障碍的冲突表现形式* 护患沟通障碍的表现形式主要是投诉,共计56次,占51.85%;频次最少的是以医疗纠纷形式出现,共计17次,占15.74%;应邀参与门诊满意度调查的22例,占20.37%;主动参与门诊满意度调查的13例,占12.04%,见表2。

表2 护患沟通障碍冲突表现形式的频数统计 (n=108)

形式	频次	百分比(%)
患者及家属的投诉		
电话投诉	29	26.85
纸质投诉	7	6.48
到办公室现场投诉	20	18.52
医疗纠纷	17	15.74
参与门诊满意度调查		
应邀参与	22	20.37
主动参与	13	12.04

2.3 *护患沟通障碍案例分析结果* 经过数据处理共提取了14个护患沟通障碍的类型。其中,费用问题出现的频次最高,共计18次,占16.67%,包括各项检查费、药品费等;最少频次的是护理人员专业知识缺乏,共计2次,占1.85%,见表3。

表3 护患沟通障碍类型的频数统计 (n=108)

类型	频次	百分比(%)
费用因素	18	16.67
患者问题未及时解答	15	13.89
医院资源配置欠合理	13	12.04
患者及家属对诊治结果不满意	11	10.19
医院管理制度	10	9.26
护理人员沟通技巧欠缺	7	6.48
护理人员语言使用不当	6	5.56
患者不良情绪	5	4.63
护理人员态度问题	5	4.63
护理人员业务技术不精	5	4.63
医院环境因素	5	4.63
护理人员主动服务意识差	3	2.78
护理人员不良情绪	3	2.78
护理人员专业知识缺乏	2	1.85

3 讨 论

3.1 *不同类型护患沟通障碍可促使门诊护患冲突的发生* (1)护患关系不仅包括了护士与患者之间的关系,而且还包括了护士与患者之间的关系,这种人际关系是医院护士的核心人际关系之一。已有数据显示,80.00%的护理纠纷是由于沟通不良或者沟通障碍导致的[3]。本研究结果显示,护患沟通障碍不再仅仅是护士单方面的原因,而是护士、患者、环境、管理等多方面的原因造成的,通过分析案例分类出14种护患沟通障碍,出现频次最高的是医疗费用的因素,表面上看这个因素,似乎跟护理完全没有关系,护理人员不是医疗费用价格的制定者,也不是产生这个费用的实施者,但最终的护患冲突却发生了。原因在于有研究显示医疗费用对患者来说是一个较为敏感、关注度较高的问题,最容易发生护患沟通障碍,从而导致护理冲突的发生,已有学校把该问题作为护患人际沟通实践教学中的一个重要考核指标[4]。(2)医院资源配置和管理也应受到足够的重视,在本研究结果中也占有了较高的比例。医院的门诊不同于医院的其他部门,患者在门诊会经历较多的繁杂流程,比如预约分诊、挂号、候诊、各类检查、交费、取各类检查结果、再次看诊、取药等,在进行这些流程的过程中尤为考验医院资源配置和管理,如果医院资源配置欠合理或者管理制度与患者及家属需求不

中国知网 https://www.cnki.net

一致,甚至欠人性化,最终导致患者在身体健康欠佳或疾病的状态下,无法得到预期的诊治,而护理人员忽视了这些因素而导致沟通障碍。(3)护理人员方面的因素导致的护患沟通障碍,这也是目前比较认可的一个重要分类,主要在于缺乏沟通理念、沟通能力有限,语言使用不当,专业知识和技术水平差,工作热情减退对患者冷漠,职业道德缺失等。随着医学理念的不断发展和更新,大众不仅关注对疾病的诊治,同时也越来越关注对门诊就诊的体验感,维权意识也增强不少,一旦自身需求无法得到及时满足或者沟通、交流不畅造成被忽视、不良感受,护患冲突一触即发。因此,探究不同类型的护患沟通障碍,有利于构建良好的护患关系,可提高门诊的护理质量。

3.2 *护患沟通障碍的原因分析* 本研究收集的临床数据显示,不管哪种类型的护患沟通障碍最终都以门诊投诉、医疗纠纷和满意度评价的形式被激化成护患冲突。因此,深层次分析护患沟通障碍的原因至关重要。(1)沟通技巧的欠缺。门诊的就诊人群几乎是社会的一个小的缩影,门诊护理人员会遇到形形色色的就诊对象,在遇到任何问题时,如果能用恰当的沟通技巧进行有效沟通和心理疏导,既使这个问题无法立即解决,患者及家属的情绪也能得到及时的缓解,可降低不良事件的发生率[5]。(2)护理工作方面。护理人员在从事护理工作时,分不清轻重缓急,辨别不了一些特殊情况,务必会出现患者问题得不到及时有效地解决。护理人员对专业知识和专业技能掌握不精,在门诊病种多、病情复杂的情况下,易出现语言使用不当和因专业知识和技术不精导致的护患沟通障碍。门诊人流量大,超负荷的工作,护理人员易出现自身的情绪不良;再加上在以医生为主的门诊诊疗中缺乏明确规范护士与患者的自主沟通,导致护理人员态度消极,缺乏主动积极性。(3)医院方面。医院整体的资源配置、基础设施等是否合理,是否满足患者及家属的需求;规章制度是否完善,是否与门诊患者需求一致;门诊管理是否合理,是否围绕"为病人服务"而进行。(4)患者及家属方面。主要包括对诊治期望值过高,强化/弱化了疾病的严重性,疾病诊治过程与患者自尊心强烈冲突,对医护人员的信任缺失,对医疗费用的不满意等。

3.3 *解决护患沟通障碍的有效对策* 为了有效解决护患沟通障碍,应采取针对性有效对策。(1)重视护患沟通,培训沟通技巧。门诊管理工作中,要不断强化服务意识,强调门诊工作中护患沟通的重要性和有效性,这不仅是尊重患者的权益,也是维护护理人员的利益。通过业务学习、继续教育、知识讲座、案例分享、纠纷讨论等多角度、多形式学习沟通技巧,提高沟通能力[6]。(2)门诊工作应选用综合素质过硬的护理人员,并定期接受专业培训。扎实的专业知识和过硬的业务能力是短时间内取得患者及家属信任的基础,也是建立良好护患沟通的重要纽带。门诊情况复杂,遇事能随机应变、沉着冷静,让患者和自己都有余地进行思考和处理问题,这需要护理人员具有良好的道德修养和人格魅力,同时具有较广的知识面。(3)优化医院资源配置和环境,以满足患者就医需求为导向。增加医院资源配置和改善环境是一个长期重大的工程,无法在短期内随意的改变,但可在现有的基础上优化医院资源配置和环境。比如可根据门诊的人流量增减预检分诊;对分诊台的咨询内容总结、分类并根据咨询时间的长短合理进行分工细化;对急重症者或者有特殊需求的患者给予特殊照顾;对易发生纠纷的事件进行整理、分类,整合资源,采取有效地对策。

综上所述,护患沟通障碍并非护士单因素、单方面造成的,其与患者、护理工作、医院之间均存在着密切的相关关系,这种沟通障碍往往导致纠纷的发生,不仅会影响医院的形象,严重者可出现肢体冲突,威胁医护人员的安全。采取积极的措施改善和解决这种沟通障碍,通过有效、积极主动的护患沟通来构建和谐的护患关系,从而保障患者安全顺利就诊。

参考文献

[1] 唐素华,唐湘冰,谭昌兰.护患沟通护理对门诊患者健康教育认知水平及护理满意率的影响[J].中西医结合护理(中英文),2024,10(3):145-147.

[2] 庞蕊.护患沟通对门诊护理质量及护理满意度的影响[J].中国城乡企业卫生,2024,39(3):214-217.

[3] 吴秀文.肿瘤门诊护理中CICARE沟通模式的应用效果分析[J].基层医学论坛,2023,27(33):148-150.

[4] 陈美金,钟玉莲,陈秀英,等.特需门诊患儿肺俞穴注射时的心理沟通需求与护理对策[J].岭南急诊医学杂志,2023,28(5):507-509.

[5] 刘文永.护患沟通技巧在门诊换药护理中的应用价值[J].黑龙江中医药,2023,52(1):237-239.

[6] 毕晓欢.护患沟通在门诊导诊护理中的应用效果[J].中国城乡企业卫生,2022,37(12):180-182.

责任编辑:刘美英,校对:董莉

中国知网 https://www.cnki.net